

OMS - Trouble bipolaire

En 2021, on estimait que 37 millions de personnes (soit 0,5 % de la population mondiale), dont environ 34 millions d'adultes, étaient atteintes d'un trouble bipolaire (1) . Ce trouble touche principalement les personnes en âge de travailler, mais aussi les plus jeunes. D'après les données disponibles, bien que sa prévalence soit quasiment la même entre les hommes et les femmes, il est plus souvent diagnostiqué chez les femmes.

À l'échelle mondiale, la couverture du traitement du trouble bipolaire est faible. Les cas sont souvent mal diagnostiqués, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. De nombreuses personnes atteintes d'un trouble bipolaire n'ont pas accès aux services et aux interventions recommandées, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes atteintes d'un trouble bipolaire sont répandues, tant dans les communautés que dans les services de santé, ce qui peut nuire à l'accès aux soins de santé. En outre, ces phénomènes favorisent l'exclusion sociale et peuvent limiter les possibilités en matière d'éducation, d'emploi et de logement.

Le trouble bipolaire est l'une des principales causes de handicap dans le monde, car il affecte de nombreux aspects de la vie. Les personnes atteintes d'un trouble bipolaire peuvent avoir des problèmes relationnels, des problèmes en milieu scolaire ou au travail, et des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes. Le trouble bipolaire augmente également le risque de suicide, ainsi que le risque d'anxiété et de troubles liés à l'usage de substances.

Les personnes atteintes d'un trouble bipolaire sont plus susceptibles de fumer, de consommer de l'alcool, de souffrir d'un problème de santé physique (par exemple, une maladie cardiovasculaire ou respiratoire) et d'avoir des difficultés à accéder aux soins de santé. En moyenne, les personnes atteintes d'un trouble bipolaire meurent 13 ans plus tôt que la population générale (2) .

Le trouble bipolaire est un problème de santé mentale qui se caractérise par des changements d'humeur extrêmes.

Une personne en phase maniaque est anormalement de bonne humeur et en forme (elle se sent exaltée, excitée, hyperactive). Elle peut ressentir un sentiment d'euphorie, avoir des sautes d'humeur ou être submergée par ses émotions (rire de façon incontrôlée ou se sentir beaucoup plus irritable ou agitée que d'habitude).

Pendant les épisodes maniaques, les changements d'humeur et de niveau d'activité s'accompagnent d'autres symptômes caractéristiques, notamment :

En revanche, lors d'un épisode dépressif, la personne se sent triste, irritable, vide). Elle ressent parfois une perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités qu'elle appréciait auparavant.

D'autres symptômes sont également présents, notamment :

Il faut distinguer l'épisode dépressif des fluctuations de l'humeur que la plupart d'entre nous connaissent : les symptômes sont présents la majeure partie de la journée, presque tous les jours, pendant au moins deux semaines.

Les épisodes maniaques et dépressifs peuvent entraîner des difficultés majeures dans la vie en général, y compris à la maison, au travail et à l'école. Ils peuvent nécessiter des soins spécialisés visant à empêcher que la personne se fasse du mal ou fasse du mal à autrui.

Certaines personnes atteintes d'un trouble bipolaire connaissent parfois des épisodes « hypomaniaques ». Les épisodes hypomaniaques se caractérisent par des symptômes similaires à ceux des épisodes maniaques, mais ils sont moins intenses et ne perturbent généralement pas autant le fonctionnement.

Il existe deux principaux types de trouble bipolaire, en fonction des épisodes maniaques ou hypomaniaques et dépressifs vécus.

On ne connaît pas la cause exacte du trouble bipolaire. Plusieurs facteurs ? notamment des facteurs biologiques (génétiques, par exemple), psychologiques, sociaux et structurels ? peuvent favoriser son apparition et influencer sur son évolution et son issue.

Des circonstances difficiles ou des événements bouleversants peuvent déclencher ou exacerber les symptômes du trouble bipolaire. Il peut s'agir d'un deuil, d'actes de violence ou d'une rupture. La consommation d'alcool ou de drogues peut également influencer sur l'apparition et l'évolution du trouble bipolaire.

Bien que le travail puisse être une source de stress pour les personnes atteintes d'un trouble bipolaire, il peut aussi être un facteur de protection. Lorsqu'il s'accompagne de bonnes conditions et d'ajustements raisonnables sur le lieu de travail, un emploi peut favoriser le rétablissement en améliorant l'aptitude à fonctionner, en réduisant les symptômes et en conduisant à une meilleure qualité de vie et à une plus grande estime de soi.

Même si les symptômes réapparaissent souvent, une guérison est possible. Grâce à des soins appropriés, les personnes atteintes d'un trouble bipolaire peuvent maîtriser leurs symptômes et mener une vie enrichissante et productive.

Il existe diverses options thérapeutiques efficaces, associant généralement médicaments et interventions psychologiques et psychosociales. Les médicaments sont essentiels dans le cadre du traitement, mais ils sont rarement suffisants pour parvenir à une guérison totale. Les personnes atteintes d'un trouble bipolaire doivent être traitées avec respect et dignité et doivent activement participer aux choix en matière de soins de santé, y compris dans le cadre d'une prise de décision commune concernant le traitement et les soins, en trouvant un équilibre entre efficacité, effets secondaires et préférences personnelles.

Les personnes atteintes d'un trouble bipolaire ont besoin d'un traitement et de soins lors des épisodes maniaques et dépressifs aigus et, le cas échéant, d'un traitement à plus long terme pour prévenir les rechutes.

Il est prouvé que les thymorégulateurs (tels que le lithium et le valproate) et les antipsychotiques aident à supporter les épisodes maniaques aigus. La prescription de lithium nécessite un suivi clinique et biologique. Les filles et les femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui sont en âge de procréer ne doivent pas prendre de valproate. Dans la mesure du possible, il faut également éviter le lithium et la carbamazépine pendant la grossesse et l'allaitement.

Les antidépresseurs sont à proscrire pendant un épisode maniaque, mais ils peuvent être associés à des thymorégulateurs ou à des antipsychotiques pendant un épisode dépressif.

Certains médicaments contre le trouble bipolaire peuvent entraîner une somnolence, des spasmes musculaires, des tremblements involontaires ou des changements métaboliques (une prise de poids, par exemple). Ces effets secondaires peuvent affecter l'observance du traitement et doivent être surveillés et pris en charge.

Les adultes atteints d'un trouble bipolaire qui sont en rémission complète (aucun symptôme) doivent généralement continuer à prendre des thymorégulateurs ou des antipsychotiques pendant au moins six mois. Les personnes ayant connu plusieurs épisodes maniaques et dépressifs auront généralement besoin d'un traitement à plus long terme pour éviter autant que possible les rechutes.

Un changement de mode de vie peut aider les personnes atteintes d'un trouble bipolaire. Il peut s'agir de maintenir un horaire de sommeil régulier, de pratiquer une activité physique, de manger sainement, de réduire les facteurs de stress ou encore d'observer son humeur.

Les interventions psychologiques (par exemple, une thérapie cognitivo-comportementale, une thérapie interpersonnelle, ou la psychoéducation) peuvent permettre d'atténuer efficacement les symptômes dépressifs et le risque de rechute.

En outre, la psychoéducation familiale peut aider les familles à mieux comprendre et à mieux soutenir leur proche atteint d'un trouble bipolaire. Le soutien de la famille et des amis est primordial. Les groupes d'entraide ? où l'on peut recevoir des encouragements, apprendre des techniques d'adaptation et partager des expériences ? peuvent être utiles aux personnes atteintes d'un trouble bipolaire et à leur famille.

Parmi les interventions psychosociales axées sur la guérison figurent les aides à l'emploi et au logement, le soutien par les pairs et la formation aux compétences sociales et de la vie courante. Elles ont pour but de nourrir l'espoir et de favoriser l'autonomie, la responsabilisation et l'inclusion sociale des personnes atteintes d'un trouble bipolaire.

Pour donner les meilleurs résultats, les médicaments et les interventions psychologiques ou psychosociales doivent être adaptés aux besoins de la personne et être combinés.

Le Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2020 présente les mesures nécessaires afin de mettre en ?uvre des services adaptés pour les personnes qui ont des troubles mentaux, y compris celles qui présentent un trouble bipolaire. L'Initiative spéciale de l'OMS pour la santé mentale vise à progresser plus avant dans la réalisation des objectifs du Plan, le but étant de garantir que 100 millions de personnes supplémentaires puissent avoir accès à des soins abordables et de qualité en matière de santé mentale.

Le Programme d'action de l'OMS Comblant les lacunes en santé mentale, qui est actuellement mis en ?uvre dans plus de 100 pays, fournit des orientations techniques, des outils et des modules de formation fondés sur des données probantes afin de renforcer les capacités et d'étendre la couverture thérapeutique pour un ensemble de maladies prioritaires, y compris le trouble bipolaire, dans les milieux non spécialisés des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les lignes directrices de l'OMS sur la prise en charge des troubles physiques chez les adultes atteints de troubles mentaux graves contiennent, à l'intention des praticiens et praticiennes, des recommandations fondées sur des données probantes concernant la façon de reconnaître et de prendre en charge les problèmes de santé physique et mentale coexistants, y compris le trouble bipolaire.

L'initiative QualityRights de l'OMS vise à améliorer la qualité des soins et le respect des droits humains dans les structures s'occupant de santé mentale et d'aide sociale, et à donner aux organisations les moyens d'agir pour défendre la santé des personnes atteintes de maladies mentales, y compris d'un trouble bipolaire.

Les orientations de l'OMS sur les services de santé mentale communautaires et les approches centrées sur la personne et fondées sur les droits décrivent ce à quoi ressemblent les approches centrées sur la personne et fondées sur les droits humains en santé mentale et donnent des exemples de services qui appliquent de

bonnes pratiques.

- (1) 2021 Global Burden of Disease (GBD) [base de données en ligne]. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2024 (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/> , consulté le 13 août 2025).
- (2) Chan JKN, Tong CHY, Wong CSM, Chen EYH, Chang WC. Life expectancy and years of potential life lost in bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. *Br J Psychiatry*. 2022;221(3):567-76 (<https://doi.org/10.1192/bjp.2022.19>).